Documento de Proceso y Mejora de XALTIL

Nombre : Jorge Ignacio García Villegas
Equipo: Webtons **Proyecto:** XALTIL
Proceso y mejora que analizamos :
Permitir al paciente conocer el nivel de saturación, disponibilidad y tiempo de espera.

1.Que debe cumplirse

- **Regla y paso donde se aplica:** Un paciente o familiar únicamente puede confirmar o reservar un turno si la plataforma verifica previamente que existe disponibilidad.
- **Como sabes que esa regla existe:** En la sección 1 (Delimitación del proceso - Entrada y Salida) y sección 2 (Stakeholders - Instituciones y normas de protección de datos), donde se especifica que el sistema debe validar datos de ocupación compartidos por los hospitales y acatar las reglas de privacidad y confidencialidad exigidas por las instituciones.
- **Quien la comprueba y con qué información :** El sistema de la plataforma en conjunto con el personal administrativo y recepción del centro de salud.
- **Un ejemplo donde se cumple y que ocurre:** Un usuario busca una consulta general en su zona. El centro de salud tiene registrada una ocupación del 70% y turnos libres. El sistema confirma la solicitud, emite un comprobante con el tiempo de espera estimado y reserva la cita sin exponer datos sensibles del paciente.
- **Un ejemplo donde no se cumple y qué ocurre:** El centro de salud alcanza el 100% de ocupación o no ha actualizado sus datos de capacidad. El sistema detecta la falta de cupo o la desactualización de datos y bloquea la emisión del turno, notificando al usuario que no hay disponibilidad momentánea e indicando otras opciones o centros médicos alternativos cercanos.

Si falta confirmarlo escribe con que la consultarías

2-¿Qué podría salir mal?

Escribe dos riesgos relacionados con el proceso o la mejora:

¿Qué podría ocurrir?	¿por qué?	¿A quién o qué actividad afectaría?	¿Qué harías para prevenirlo y atenderlo?
Muestra de tiempos o disponibilidad desactualizados.	El personal administrativo no actualiza inmediatamente por exceso de trabajo.	Afecta al paciente o a la familia y harán desplazamientos innecesarios.	**Prevención:** Hacer un mecanismo de recordatorios automáticos para confirmar cupos **Atención:** Mostrar un indicador de la última actualización de estado.
Falta de disposición de los centros para compartir los datos	Temor a exponer datos institucionales internos o incompatibilidad de sus sistemas existentes	Afecta el alcance del proyecto, impidiendo ofrecer opciones en determinadas zonas o clínicas de salud.	**Prevención:** Diseñar un módulo simplificado que no sature la carga de trabajo del personal y anonimización de datos **Atención:** Realizar pruebas demostrando el valor de la distribución coordinada de la demanda de pacientes

3-¿Qué necesitamos?

¿Que revisa?	Tu respuesta
Herramientas y datos: ¿que necesitamos, que tenemos y que falta comprobar?	**Necesitamos:** API o base de datos de los centros de salud para consultar saturación y tiempos de espera en tiempo real, servicios de mapas/geolocalización para calcular tiempo de traslado. mapas/geolocalización para calcular tiempo de traslado. **Tenemos:** Definición del proceso, propuesta de valor e identificación de los datos de entrada/salida. **Falta comprobar:** Si los centros de salud permitirán integrar o sincronizar sus sistemas con nuestra plataforma.
Personas:¿ quien lo usaría, quien revisaría y que tendría que aprender?	**Quién lo usaría:** Pacientes, familiares y personal de recepción/administrativo de los centros de salud. **Quién revisaría:** Equipo técnico que mantiene la plataforma y administradores de los centros de salud. **Qué tendría que aprender:** El personal administrativo requerirá una capacitación básica y breve para actualizar los estados de disponibilidad sin entorpecer sus actividades diarias.
Tiempo y recurso: ¿que equipo, acceso, tiempo o costo requiere y con que contamos?	**Requiere:** Servidores de alojamiento web, licencias de APIs de mapas, permisos de acceso a datos de prueba de clínicas y tiempo de desarrollo para la integración técnica

4- Termina tu análisis

La mejora puede funcionar si se logra que los centros de salud compartan y actualicen la disponibilidad de forma constante, porque depende directamente de que los pacientes tomen decisiones fundamentadas antes de desplazarse.- Lo que falta comprobar es si la información de los centros que tienen diferente sistema interno se puede integrar correctamente y lo averiguaré mediante entrevistas con administradores hospitalarios y pruebas técnicas de integración con datos .

Si consideras que aún no puede aplicarse, explica que lo impide. Si no falta información, indica que fuentes respalda tu información

Fuentes utilizadas

Secretaría de Salud / COFEPRIS: *NOM-024-SSA3-2012: Sistemas de información de registro electrónico para la salud. Intercambio de información en salud.* (Norma Oficial Mexicana que regula la confidencialidad, privacidad, trazabilidad e interoperabilidad de los datos de salud digitales en México).

Diario Oficial de la Federación (DOF): *Marco legal sobre Protección de Datos Personales y Expediente Clínico Electrónico en Centros de Salud*.

Uso de IA

Durante la elaboración de este documento se utilizó Inteligencia Artificial (Gemini) como apoyo para la organización de las ideas, dar formato y buscar información que no facilitara posibles soluciones.